



I. LAPORAN KEJADIAN

1	Pembuat Kronologi	Ns. Bella Fitra Mardatillah, S.Kep.
2	Kejadian	Missed Inputan Billing Laborat BTA Pasien
3	Unit Kerja yang terlibat	Laboratorium, IRNA 2A
4	Tanggal Kejadian	18 November 2023

II. KRONOLOGIS KEJADIAN (dijelaskan secara detail hari dan jam kejadian)

Tanggal	Jam	Kronologi	Staf yang terlibat
Irna 2A			
18 November 2023	14.00	Perawat Mutia melakukan <i>handover</i> dengan Perawat Deva terkait pasien atas nama Tn. M. Alimin (RM: 085087). dan Tn. Karminto. Perawat Mutia mengatakan bahwa pasien Tn. Alimin rencana cek BTA cairan hasil punksi pleura dan telah diinput di billing pasien. Perawat Deva menerima <i>handover</i> tersebut, namun sampel masih ada di Nurse Station.	Perawat Mutia dan Perawat Deva
	16.30	Perawat Bella yang melihat sampel tersebut belum dikirim ke lab, akhirnya menurunkan sampel tersebut ke lab. Sesampainya di lab, Laborat Bu Parmi dan Laborat Nova menerima sampel yang dibawa Perawat Bella. Laborat Parmi menanyakan, "Kertas form hijaunya mana mbak?". Perawat Bella menjawab, "Form hijau apa nggeh bu?". Kemudian Laborat Parmi dan Nova memberi form hijau untuk pengiriman sampel tersebut kepada Perawat Bella. Perawat Bella mengisi form hijau tersebut di lab untuk masing-masing sampel, yaitu milik Tn. M. Alimin dan Tn. Karmanto. Perawat Bella juga mengingatkan perihal inputan billing oleh Laborat Parmi. Saat itu, Perawat Bella segera menelpon Unit IRNA 2A untuk meminta bantuan konfirmasi diagnosa terbaru pasien dan inputan billing. Adapun yang menerima telepon adalah Perawat Eriq. Perawat Eriq ketika itu merespon dengan cepat dan langsung menginput billing pemeriksaan BTA kedua pasien tersebut. Setelah form hijau terisi, Perawat Bella menunggu Laborat Parmi yang mengecek isian form hijau, lalu meninggalkan lab setelah form hijau selesai dicek.	Perawat Bella, Perawat Eriq, Laborat Parmi, Laborat Nova
Laboratorium			
18 November 2023	16.30	Laborat Nova dan Bu parmi menerima sampel cairan pleura yang dikirim perawat bella. perawat bella datang ke laboratorium membawa 2 sampel cairan pleura kemudian menuliskan dibuku penerimaan sampel untuk pemeriksaan analisa cairan pleura. kemudian bu parmi menanyakan kertas pengantar untuk pemeriksaan sitologi cairan pleura dan, Oleh karena itu perawat Bella diminta untuk melengkapi pengantar kertas hijau serta diminta untuk menginput pemeriksaan sitologi cairan pleura ke SIMRS.	Laborat Nova, Laborat Parmi, Perawat Bella



	Lalu Bu parmi dan laborat nova menjelaskan bahwa adanya pemeriksaan sitologi cairan pleura dan bukan Analisa cairan pleura, dan apabila permintaanya sitologi pleura maka harus disertakan kertas hijau untuk pengantar pemeriksaan Sitologi cairan pleura. kemudian perawat bella menelfon 2A untuk menginputkan pemeriksaan sitologi cairan pleura. Kemudian perawat bella meninggalkan lab untuk mengambil kertas pengantar hijau untuk pemeriksaan sitologi pleura.	
17.00	Kemudian perawat bella datang kembali ke laboratorium dengan membawa kertas pengantar hijau. Setelah menerima sampel dan pengantar kertas hijau yang sudah di cek oleh Laborat Bu Parmi dan diinformasikan dengan estimasi 2 minggu (14 hari). Laborat Nova mempacking sampel tersebut untuk dikirimkan. Petugas laborat shift siang tidak melakukan crosscheck untuk inputan billing dan juga tidak mengoperkan kepada petugas shift selanjutnya. Kemudian petugas laboratorium yang shift siang mengoperkan sampel tersebut ke shift berikutnya untuk dilakukan pengiriman sampel pada hari senin ke RSUD Bangil.	



Bukti handover pasien Tn. Alimin dari Perawat Mutia ke Perawat Deva

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

RMIG 4

RM 13.7/REV 01

MALAM
02/05/2023 - 02/05/2023 15.00
080027

Ans: S. TB Parv + S. Epu Pleura
dr. Fitri Sp.P.

LAPORAN OPERAN PASIEN (LOP)

Riwayat Alergi: -
Kamar: 1502

PAGI
11/11/23 ... / 12.00

SIANG
... / 19.00

MALAM
... / 08.00

SITUATION (S)
Perubahan jalan napas
wheezing

BACKGROUND (B)
batuk berdahak

Caru Bayar: BPJS 3

Perubahan status batuk
tidak efektif

batuk

GCS
E4 V5 M6

TD: 100/60 mmHg N: 90 x/menit
RR: 20 x/menit Tax 37.8°C
SpO2 96%
☐ Dekubitus
☐ Jatuh/Cidera
☐ Ya / Tidak, di ...
☒ O₂ 2L - 3 l/min dg NC
☐ Inf terpasang / tidak
☐ Skin test Antibiotik: +/-
☐ CATH: ...
☐ NGT: ...
☐ Angkat Kepala: ...
☐ Miki/ Miki: ...
☐ Semi Fowler: ...
☐ MSS: ☐ Cair: ...
☐ BH: ☐ BK: ...
BAB: +/- kali
Konsistensi: Wama: ...
BAK: +/- UT: cc / jam
wama: Terbuang / tidak terbuang

TD: 100/60 mmHg N: 90 x/menit
RR: 20 x/menit Tax 37.8°C
SpO2 96%
☐ Dekubitus
☐ Jatuh/Cidera
☐ Ya / Tidak, di ...
☒ O₂ 2L - 3 l/min dg NC
☐ Inf terpasang / tidak
☐ Skin test Antibiotik: +/-
☐ CATH: ...
☐ NGT: ...
☐ Angkat Kepala: ...
☐ Miki/ Miki: ...
☐ Semi Fowler: ...
☐ MSS: ☐ Cair: ...
☐ BH: ☐ BK: ...
BAB: +/- kali
Konsistensi: Wama: ...
BAK: +/- UT: cc / jam
wama: Terbuang / tidak terbuang

TD: 100/60 mmHg N: 90 x/menit
RR: 20 x/menit Tax 37.8°C
SpO2 96%
☐ Dekubitus
☐ Jatuh/Cidera
☐ Ya / Tidak, di ...
☒ O₂ 2L - 3 l/min dg NC
☐ Inf terpasang / tidak
☐ Skin test Antibiotik: +/-
☐ CATH: ...
☐ NGT: ...
☐ Angkat Kepala: ...
☐ Miki/ Miki: ...
☐ Semi Fowler: ...
☐ MSS: ☐ Cair: ...
☐ BH: ☐ BK: ...
BAB: +/- kali
Konsistensi: Wama: ...
BAK: +/- UT: cc / jam
wama: Terbuang / tidak terbuang

ASSESMENT (A)
P/ BTA Habi

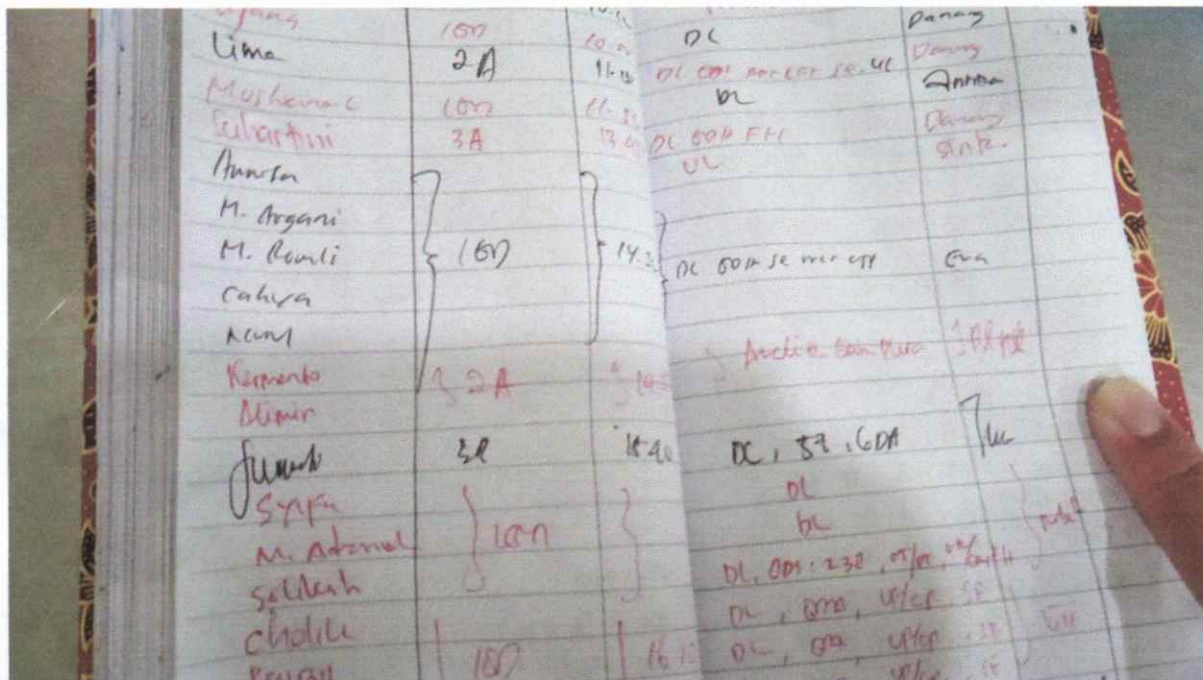
RECOMMENDATION (R)
Pemeriksaan dc.
K 17 cm C. bchc (+)
J. puke: pleura (+), dan oai.
dan cek BTA pleura - drain dan
7 hari (+) (+) (+)

DC pendakan, form (+)
R/tem (+) bati (+)
Hanya utang X
R/ puke: paru 500 cc
Ocut - R/ Bta caru pleura (+)

Pemberi Pesan: Nafn.
Penerima Pesan: P. deva
Pemberi Pesan: P. deva
Penerima Pesan: P. deva
Pemberi Pesan: P. deva
Penerima Pesan: P. deva



Bukti penerimaan Sampel dan Form Rujukan Sitologi Cairan Pleura :



**RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA**

Jl. Raya Surabaya - Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo - Pasuruan
Telp : 0343 - 6745000
website : www.rs-primahusada.com

SB 145/23
dr. TB
22/11/23

**FORMULIR PERMINTAAN PEMERIKSAAN PATOLOGISITOLOGI
PATOLOGI ANATOMI**

PENDERITA
Nama : ALIMIN
Umur : 62/03/1963 - 42 th 6 bln 15 hr
Pekerjaan : 08087
Alamat : Jln. Kel. L.
Kodya/kabupaten : KOTA SURABAYA
Dari Rumah Sakit : RS PRIMA HUSADA SURABAYA Kelas : Reg No :

PENGIRIM
Nama :
Alamat :
Reg No :

Bahan : Jaringan Padat/Cairan/Smear/FNAB
Fiksasi : Untuk PA : Formalin 10%
Untuk Sitologi : Sputum alkohol 70% Urine alkohol 60%
Vaginal smear alkohol 95%

Lokalisasi : Pleura (P)
Diagnosa Klinik : Suspek TB paru - Efusi Pleura (P)
Jenis Operasi :

KETERANGAN KLINIK :

KETERANGAN LAIN-LAIN :

Bila pernah diperiksa No PA/NO Sitologi :

DISI OLEH LABORATORIUM
No Reg :
Terima Tanggal :
Selesai Tanggal :
Sisa bahan diambil/tidak :
Syarat dan Ketentuan :
Pengisian terhadap bahan sedimen, sld & block diserahkan kepada bagian laboratorium. Jika dalam waktu 4hr setelah hasil pemeriksaan diterima, tidak ada permintaan dari pasien/keuarga untuk pengembalian bahan sedimen/blockade

Pasuruan 18/11/23

**RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA**

Jl. Raya Surabaya - Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo - Pasuruan
Telp : 0343 - 6745000
website : www.rs-primahusada.com

SB 146/23
dr. ay
22/11/23

**FORMULIR PERMINTAAN PEMERIKSAAN PATOLOGISITOLOGI
PATOLOGI ANATOMI**

PENDERITA
Nama : KARMANTO
Umur : 19/04/1965 - 58 th 6 bln 24 hr
Pekerjaan : 084775
Alamat : Jln. Kel. L.
Kodya/kabupaten : KOTA SURABAYA
Dari Rumah Sakit : RS PRIMA HUSADA SURABAYA Kelas : Reg No :

PENGIRIM
Nama :
Alamat :
Reg No :

Bahan : Jaringan Padat/Cairan/Smear/FNAB
Fiksasi : Untuk PA : Formalin 10%
Untuk Sitologi : Sputum alkohol 70% Urine alkohol 95%

Lokalisasi : Pleura (P)
Diagnosa Klinik : Suspek TB paru - Efusi Pleura (P)
Jenis Operasi :

KETERANGAN KLINIK :

KETERANGAN LAIN-LAIN :

Bila pernah diperiksa No PA/NO Sitologi :

DISI OLEH LABORATORIUM
No Reg :
Terima Tanggal :
Selesai Tanggal :
Sisa bahan diambil/tidak :
Syarat dan Ketentuan :
Pengisian terhadap bahan sedimen, sld & block diserahkan kepada bagian laboratorium. Jika dalam waktu 4hr setelah hasil pemeriksaan diterima, tidak ada permintaan dari pasien/keuarga untuk pengembalian bahan sedimen/blockade

Pasuruan 18/11/23



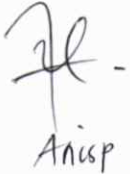
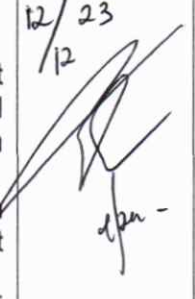
III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

IRNA 2A
1. Laborat kurang teliti dalam melakukan pengecekan inputan billing pemeriksaan lab, Dimana unit lab akan melakukan konfirmasi ke unit IRNA jika billing belum terinput, namun pada kasus tersebut tidak ada konfirmasi apapun dari Unit Lab. 2. Perawat IRNA belum konsisten melakukan pengecekan inputan billing sebelum mengirimkan sampel di Unit Lab, sehingga terkadang inputan diinputkan ketika pengirim sampel sudah berada di Lab.
LABORATORIUM
1. Perawat irna tidak konfirmasi tentang pemeriksaan yang akan diperiksa terlebih dahulu kepada staff laboratorium, sehingga penginputan pemeriksaan yang harusnya preparat BTA menggunakan sampel pleura menjadi diperiksa sitologi pleura. Apabila diawal perawat mengkonfirmasi bahwa pemeriksaanya BTA maka akan dikerjakan di laboratorium RSPHS tanpa harus dirujuk ke RSUD Bangil. 2. Petugas laboratorium belum konsisten melakukan pengecekan apabila ada inputan pemeriksaan rujukan, sehingga terjadi tidak terinputnya pemeriksaan rujukan sitologi cairan pleura.

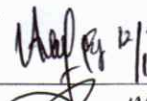
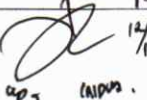
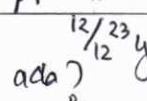
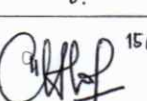
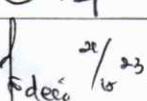
IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Instansi maupun petugas terkait dapat mengalami kerugian karena pemeriksaan tanpa inputan billing tidak dapat ditanggung oleh BPJS yang mana instansi/petugas terkait harus mengganti rugi sejumlah biaya pemeriksaan tersebut.
--

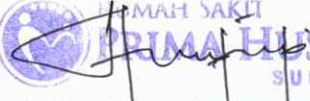
V. TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT

Jabatan	Tanggapan dan Tindak Lanjut	TTD
Kepala Ruang Unit IRNA 2A	Permasalahan : 1. Perawat tidak melakukan komunikasi dengan jelas saat melakukan asistensi DPJP (BTA Pleura atau sitologi pleura) sehingga komunikasi antara perawat dan petugas Laboratorium tidak jelas. 2. Kepala Tim tidak memastikan atau konfirmasi ulang kepada DPJP terkait pemeriksaan (BTA Pleura atau sitologi pleura) 3. Perawat penanggungjawab pasien tidak melakukan konfirmasi ulang kepada perawat yang melakukan Asistensi DPJP 4. PPJA lain saat mengantarkan sampel Lab tidak mengetahui permintaan pemeriksaan Lab yang dimaksud. Tindaklanjut : 1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Ruang Laboratorium 2. Melakukan koordinasi dengan Tim Keuangan rumah sakit terkait Pemeriksaan yang belum terinput pada Billing SIMRS 3. Membuat kronologi dan menginput pada Simrs IKP 4. Melakukan monitoring evaluasi terkait IKP	 Anis
Kepala Ruang Unit Laboratorium	Permasalahan : 1. Handover dari perawat yang kurang tepat mengakibatkan kesalahan awal penerimaan sampel yang harusnya pemeriksaan BTA dengan bahan cairan pleura, tetapi menjadi sitologi cairan pleura. 2. PJ Shift tidak memastikan penginputan kedua pasien yang sampelnya sudah dilaboratorium dan membuat pengantar rujukan. 3. pemeriksaan yang belum terinput baru diketahui pada bulan berikutnya tidak pada proses akan KRS.	12/23 12  dan -



	Tindaklanjut : 1. Melakukan kordinasi dengan kepala irna 2A terkait kronologi kejadian tidak terinputnya pemeriksaan laboratorium. 2. melakukan kordinasi dengan kabid penunjang medik dan kepala keuangan Rumah Sakit. 3. Melakukan kordinasi dengan PJ Admin untuk pengecekan berkala atas sampel rujukan.	
Kepala Ruang Unit		
*Kepala Keuangan RS	1. Sebelum Kirim sample pastikan tindakan sudah terinput. 2. Eksekusi kembali sebelum Rk. KRS.	 12/12/23
*Kabid Pelayanan Medik	1. Operan bisamping pasien dan dalam OP harus sesuai dengan perintah OPJP dalam CPPT 2. Saat membungkus/mengantarkan sample ke labort harus paham cek ap. insus.	 12/12/23
*Kabid Keperawatan	1. SPO operan apakah sudah ada ? 2. SPO pemeriksaan penunjang apakah sudah ada ? - TL sesuai dengan peraturan yang berlaku	 12/12/23
*Kabid Penunjang Medik	1) Tingkatkan ketelitian, double check 2) Jalankan sesuai regulasi yang ada	 15/12/23
*SDM RS	1. Review SPO → Sosialisasikan kembali 2. Kerugian akan ditanggung oleh 2 unit ybs → Rp. 200.000 3. Botol/gas → Memon info nominal yg harus ditanggung	 21/12/23

Menyetujui
Direktur RS Prima Husada


PRIMA HUSADA
SUKOREJO

dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS

Pembuat Kronologi



(Ns. Bella Fitra Mardatillah, S.Kep.)

Catatan Direktur : _____